Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 24ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810223

Processo nº 0031069-47.2022.8.17.2001

AUTOR(A): MARIA ENEIDE DE NOVAES LEITAO QUEIROZ
ESPÓLIO - REQUERENTE: PATRICIA FLORA LEITAO QUEIROZ, TEREZA CHRISTINA LEITAO QUEIROZ

RÉU: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

S E N T E N Ç A

Vistos etc.,

MARIA ENEIDE DE NOVAES LEITÃO QUEIROZ, qualificada e representada nos autos, intentou a presente *ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais*, em desfavor de **FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ**, também identificada.

Aduziu, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde da ré e que foi diagnosticada com câncer de mama (carcinoma metastático), quando realizou mastectomia e ressecção de linfonodo, em 31/03/16.

Seguiu alegando que, posteriormente, em novembro/2019, foi mais uma vez diagnosticada com carcinoma urotelial papilífero grau 3, tendo sido submetida à retirada do ureter e segmento da bexiga em monobloco. Seis meses antes do ingresso em juízo, informou que foi constatada nova tumoração na região indguino crural direita, com invasão óssea, e nos pulmões.

Referiu que, após vários tratamentos, a médica assistente prescreveu a imunoterapia com "Atezolizumabe" ou "Pembrolizumabe (Keytruda)" para tentativa de melhora do seu quadro de saúde, todavia afirmou que o referido medicamento fora negado pelo réu.

Pugnou, inclusive em sede de tutela de urgência, que o demandado seja compelido a fornecer o medicamento "Pembrolizumabe (Keytruda)", nos moldes receitados pelo médico assistente. No mérito, pediu a confirmação da tutela, a declaração de nulidade da cláusula contratual limitativa e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Juntou documentos. Recolheu custas.

Concedida a tutela de urgência pretendida, foi determinada a citação da parte adversa (ID 102030092).

Citada, a ré apresentou contestação (ID 103567546), na qual alegou preliminarmente a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, porquanto se trata de entidade de autogestão. No mérito, aduziu que não há cobertura obrigatória do medicamento, uma vez que se trata de uso *off label*. Defendeu a legalidade de sua conduta e a inexistência de danos morais indenizáveis. Por fim, requereu a total improcedência da ação. Juntou documentos.

Noticiado o falecimento da parte autora, foi realizada a habilitação das herdeiras Patrícia Queiroz e Tereza Queiroz, filhas da extinta (ID 110175493).

Réplica apresentada (ID 121327574).

Intimadas as partes para provas, a ré requereu a expedição de ofício à ANS, NATJUS e CONITEC para informar nos autos a cobertura e efetividade do medicamento sugerido (ID 123334619).

Deferido o requerimento, foram expedidos os ofícios.

Resposta da ANS apresentada nos autos (ID 143003713).

É o Relatório. Decido.

De chofre, importa destacar que o feito comporta julgamento antecipado, visto que a matéria de mérito, embora de fato e de direito, dispensa a produção de prova em audiência, *ex vi* do disposto no art. 355, I, do novo Código de Processo Civil.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em sede da qual pretendia a autora compelir a seguradora ré a autorizar e custear o tratamento de graves patologias de que era portadora, condenando-se, ainda, a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados em decorrência da recusa injustificada.

Ocorre que, no curso processual, sobreveio a notícia do falecimento da promovente, conforme ID 104387813.

Como é cediço, havendo o falecimento da parte (autor ou réu) e sendo o direito material posto em causa intransmissível por expressa disposição legal, deve o processo ser extinto sem enfrentamento do mérito. Por outro lado, é igualmente sabido que o direito de exigir reparação transmite-se com a herança, nos termos do art. 943, do Código Civil.

In casu, como visto, a pretensão resistida consiste na autorização e custeio de tratamento médico e, ainda, na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ora, é por demais óbvio e natural que, diante da morte do usuário do plano de saúde, não mais tem sentido falar em autorização e cobertura de tratamento de saúde. Deve tal pretensão (de obrigação de fazer), assim, ser extinta com fulcro no art. 485, incisos VI e IX, do CPC.

De outro giro, o direito à indenização por violação moral transmite-se com o falecimento do titular do direito, ou seja, tanto os herdeiros quanto o espólio têm legitimidade ativa para ajuizar ação de reparação por danos morais. Registre-se, nesse ponto, que o direito que se sucede é o de ação, de caráter patrimonial, e não o direito moral em si, personalíssimo por natureza e, portanto, intransmissível.

Nesse sentido, recente tese do Superior Tribunal de Justiça:

"Embora a violação moral atinja apenas os direitos subjetivos do falecido, o espólio e os herdeiros têm legitimidade ativa ad causam para pleitear a reparação dos danos morais suportados pelo de cujus".

A propósito, esclarece o STJ, em voto da lavra da Min. Nancy Andrighi, que, "*Embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima,* ***o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus****. Precedentes. 2. Se o espólio, em ação própria, pode pleitear a reparação dos danos psicológicos suportados pelo falecido, com mais razão deve se admitir o direito dos sucessores de receberem a indenização moral requerida pelo de cujus em ação por ele próprio iniciada*"(REsp. 1.071.158/RJ). (grifos nossos).

Ainda sobre o tema, Carlos Alberto Bittar também leciona:

"Ajunte-se, por derradeiro, que é perfeitamente possível a transmissão do direito à reparação, operando-se a substituição processual com a habilitação incidente, em caso de falecimento do lesado no curso da ação, como, de resto, ocorre com os demais direitos suscetíveis de translação. (C. Civil. Art. 1.526 (de 1996), e CPC, art. 43)" (Reparação Civil por Danos Morais.1993. p.150).

Em assim sendo, fica restrito o objeto da ação apenas ao pedido de reparação por danos morais.

Passo, então, ao exame do mérito.

Aduz a parte autora que, diante de todas as aflições e transtornos sofridos em decorrência da conduta da operadora demandada, faz jus ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

De outro flanco, a ré defendeu a ausência de prova de que a autora tenha sido exposta a acontecimentos vexatórios que tenham maculado o seu íntimo ou mesmo a prática de ato ilícito capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

Cinge-se a lide, portanto, em saber se era devido o custeio da medicação *off label* para o tratamento da doença que acometia a autora e se, caso ilícita, foram gerados danos morais indenizáveis na espécie.

Resta incontroverso que o *de cujus* fora diagnosticado como portador de neoplasia maligna em metástase, necessitando submeter-se a tratamento com a droga Pembrolizumabe (keytruda), conforme laudos médicos apresentados.

Sobre as questões aqui colocadas, sabe-se que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp nº 1.886.929 – SP, unificou o entendimento entre suas Turmas de Direito Privado acerca da taxatividade ou não do rol de procedimentos e eventos em saúde elaborado pela ANS.

No referido julgado, foi fixada a seguinte tese:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. (STJ - EREsp: 1886929 SP 2020/0191677-6, Data de Julgamento: 08/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2022).

Assim, prevaleceu o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, porém comporta exceções, na forma prevista acima ("taxatividade mitigada").

Ocorre que a demanda *sub judice* não versa sobre medicamento excluído do rol da ANS, e sim de fármaco que, embora incorporado, é destinado, em regra, ao tratamento de patologia específica diversa da autora (o chamado uso *off label*).

Outrossim, o laudo médico de ID n° 101986787, assinado por oncologista habilitada (CRM-6895), atesta que, no caso da autora, há necessidade de utilização do fármaco em questão, porquanto se trata de paciente com idade avançada, acometida por vários tumores e comorbidades, impossibilitada de receber quimioterapia.

Registre-se ainda que a Lei n° 9.656/1998, em seu art. 12, I, alínea "c", determina a obrigatoriedade de cobertura, pelos planos de saúde, dos tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, nos seguintes termos:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

Em tais circunstâncias, os Tribunais têm entendido que, se a patologia em questão possui cobertura pelo plano, existe prescrição médica fundamentada e o medicamento prescrito é incorporado à lista da ANS, afigura-se abusiva a negativa de fornecimento pela operadora, ainda que o fármaco seja destinado a uso *off label*, vez que a indicação do tratamento adequado cabe exclusivamente ao médico responsável pelo paciente.

Há vários precedentes neste sentido, conforme recentes julgados abaixo colacionados:

PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura do tratamento com os fármacos Keytruda (Pembrolizumabe) 200mg e Lenvima (Mesilato de Lenvatinibe 14 mg) – Abusividade – Aplicação do CDC – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Obrigatoriedade da cobertura do fornecimento do medicamento ainda que para uso off label segundo a ANVISA - Precedentes do STJ e aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP – Obrigatoriedade do fornecimento do medicamento diante da prescrição médica – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10091886520218260001 SP 1009188-65.2021.8.26.0001, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 26/04/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DO COLO DO ÚTERO. USO DE PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. ABUSIVIDADE.DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A recomendação para a utilização do medicamento é do profissional que detém o conhecimento técnico sobre o melhor tratamento a ser adotado, não cabendo às operadoras substituírem os técnicos neste mister, sob pena de se pôr em risco a vida do consumidor. 2. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, devendo apenas ser registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente. 3. É abusivo o ato que negou à consumidora o direito a ter o medicamento antineoplásico indicado pelo seu médico assistente, devendo o plano de saúde indenizar em danos morais. 4. Considerando a função educativo-punitiva da indenização por danos morais, a extensão do dano e as variáveis do caso concreto, é razoável a fixação da verba compensatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso não provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0032100-39.2021.8.17.2001, em que figura como Apelante Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico, e, como Apelada Suemi Kaneko Lindoso, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator. Recife/PE, data da assinatura digital. SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO Desembargador Relator (TJ-PE - AC: 00321003920218172001, Relator: JOAO JOSE ROCHA TARGINO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. NEOPLASIA DE ENDOMÉTRIO. MEDICAÇÃO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). INDICAÇÃO OFF LABEL. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que a autora requer autorização para que o plano de saúde requerido autorize seu tratamento de saúde com o medicamento ?pembrolizumabe?, nome comercial: Keytruda, para realização das suas sessões de radioterapia e de imunoterapia. 2. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 3. Firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. 4. O rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. 4.1. No entanto, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. 5. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN nº 428/ANS). 6. Precedente jurisprudencial do STJ: ?(...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato? (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2019) 7. Precedente jurisprudencial do TJDFT: ?(...) Não compete ao plano de saúde perquirir a forma de tratamento destinada ao controle da moléstia da qual o paciente foi acometido, devendo seguir a indicação do médico especialista, pois o prestador de serviços pode limitar as doenças cobertas pelo contrato de assistência médica, mas não os tratamentos, sob pena de esvaziamento da função precípua do contrato de plano de saúde. Precedentes STJ e TJDFT. 3. O fornecimento de medicamento indispensável para tratamento de doença coberta pelo contrato de plano de saúde, desde que indicado pelo médico especialista, é medida que se impõe. Obrigação que exsurge principalmente na hipótese em que a bula do medicamento "Keytruda" contempla o diagnóstico da paciente. 4. Confirmada a obrigação do plano de saúde em custear o tratamento pleiteado faz-se necessário o ressarcimento do gasto da consumidora com a primeira sessão de imunoterapia com a aplicação do fármaco, com as devidas atualizações monetárias. 5. Recurso desprovido?. (07319152720188070001, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5ª Turma Cível, DJE: 22/5/2019?.) 8. Portanto, tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora determinar qual o tratamento. 8.1. Havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento. 9. Assim, deve ser concedida a tutela pretendida, a fim que a agravada autorize a realização do tratamento e o custeio do medicamento prescrito. 10. Recurso provido. (TJ-DF 07400237720208070000 DF 0740023-77.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 04/11/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Entidade de autogestão. Inaplicabilidade do CDC (Súmula nº 608 do C. STJ) que não afasta a abusividade da negativa de fornecimento de tratamentos pelo fato de não constarem no rol da ANS. Inteligência da Súmula nº 102 do E. TJSP e da Lei nº 9.656/98. Precedentes desta C. Câmara – Neoplasia maligna hepática – Continuidade do tratamento com imunoterapia. Uso off label dos medicamentos de Keytruda, Ansentron e Difenidrin. Prescrição por médico que acompanha o paciente. Necessidade incontroversa – Alteração da Lei nº 9.656/98 pela Lei nº 14.454 de 21 de setembro de 2022. Rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar que constitui referência básica para os planos de saúde. Cobertura que deverá ser autorizada se comprovada a eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ("rol exemplificativo") – Incabível a inversão da sucumbência (art. 86, parágrafo único, do CPC)– Recurso desprovido.(TJ-SP - AC: 10636347520228260100 SP 1063634-75.2022.8.26.0100, Relator: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 15/12/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

Não há dúvidas, portanto, de que, no caso em exame, a negativa de cobertura está em desacordo com as normas e princípios previstos do nosso ordenamento e jurisprudência dominante.

Tratando-se de contrato de seguro-saúde, inegável que as normas nele previstas devem procurar garantir o respeito à vida e saúde de seus segurados. Acima de qualquer outra consideração, não se pode perder de vista que a vida e a saúde das pessoas são bens jurídicos de valor inestimável e, por isso mesmo, tutelados pela Constituição Federal (artigos 196 e seguintes).

É, pois, abusiva a negativa de cobertura estabelecida pela ré, de modo que resta caracterizada a prática de ato ilícito pela empresa demandada.

Quanto aos danos morais propriamente ditos, perfilho do entendimento da Corte Superior de Justiça de que há direito ao ressarcimento do dano moral oriundo da injusta demora/negativa de autorização/custeio de cobertura médica, pois esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, caracterizado por grave ofensa à dignidade da pessoa humana.

Nessa linha:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 157 DO RISTJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CONDENAÇÕES DE NATUREZAS DISTINTAS. BASE DE CÁLCULO. PEDIDO DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA A AÇÃO. ***1. A recusa, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, implica dano moral ao conveniado, na medida em que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele que necessita dos cuidados médicos. Precedentes.*** *2. A desnecessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos viabiliza a aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, com a fixação da indenização a título de danos morais que, a partir de uma média aproximada dos valores arbitrados em precedentes recentes, fica estabelecida em R$12.000,00. 3. Em processos em que houver condenações de naturezas distintas, surgindo dúvida quanto à forma de arbitramento dos honorários advocatícios - se com base no § 3º ou no § 4º do CPC - a verba deve ser fixada tendo em vista o objeto central da controvérsia, isto é, o pedido e a causa de pedir que assumirem maior relevância para a ação. 4. Recurso especial provido (REsp 1235714/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012). (destaques nossos).*

Com efeito, na hipótese discutida no presente feito, inquestionável a profunda dor psíquica, diante da incerteza de cobertura, em função de que a ré, que então estava obrigada a prover os recursos necessários para o tratamento e procedimentos médicos devidos, omitiu-se naquele momento delicado, não se podendo olvidar que a autora, à época, tratava-se de pessoa portadora de doenças graves.

Assim sendo, pelas circunstâncias fáticas e provas produzidas em Juízo, entendo perfeitamente caracterizado na espécie o prejuízo imaterial alegado pela parte postulante, cujo montante arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), solução que reputo mais justa e equânime para o caso.

Por esses fundamentos, ante o exposto, ao tempo em que julgo extinto sem apreciação meritória o pedido autoral de obrigação de fazer (fornecimento/custeio de medicamento), o que faço com supedâneo no art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão indenizatória, condenando a ré ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida pela tabela do ENCOGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento, conforme entendimento, quanto à correção, consubstanciado na Súmula 362 do STJ, e, quanto aos juros, adotado pela 4ª Turma do STJ no julgamento do REsp 903258, segundo o qual a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou.

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que estabeleço em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se.

Recife, 22 de janeiro de 2024.

Patrícia Xavier de Figueirêdo Lima

JUÍZA DE DIREITO

Assinado eletronicamente por: PATRICIA XAVIER DE FIGUEIREDO LIMA
22/01/2024 12:02:41
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 157999562

24012212024153000000154333078

IMPRIMIR GERAR PDF